

PRD — Plataforma Pin Saúde (MVP)

Product Requirements Document · v1.1 (final)

Produto	Plataforma de gestão para PJ médica (faturamento, emissão fiscal, repasse e gestão)
Cliente	Pin Saúde
Versão	1.1 (consolidação das Rodadas 1–3 de discovery + apontamentos da operação)
Stack	React · Java 17 / Spring Boot · PostgreSQL · Playwright (e2e)
Status	Final — base aprovada para o backlog do MVP

Este PRD consolida as três rodadas de apuração com a operação e os apontamentos devolvidos pela equipe da Pin sobre o draft v1.0. Os pontos fiscais aqui descritos refletem o que a contabilidade da Pin informou e devem ser **parametrizáveis** no sistema (não são parecer fiscal). Itens ainda abertos estão na Seção 13.

O que mudou na v1.1 (apontamentos da operação incorporados ao draft v1.0):

- §5.2 — adicionada a transição da **reforma tributária (IBS/CBS)** para serviços de saúde humana (NBS 200029, Anexo III, redução de 60%, início em 2027 com fase de 1%), como premissa parametrizável.
- §5.2/§5.3 — esclarecido o caso de **paciente pessoa física (CPF) com equiparação hospitalar**: NFS-e emitida com impostos **zerados** (sem destaque e sem retenção na nota); tributos apurados pela contabilidade e recolhidos à parte; médico continua recebendo 85%. Propagado para RF-NF-02 e RF-FISC-02.
- §12 (Fase 2) — incluído **controle de produção de vários médicos para o mesmo tomador** (ex.: ~40 médicos no mesmo hospital).

1. Sumário executivo

A Pin Saúde permite que médicos faturem seus honorários por meio da estrutura jurídica da empresa (um CNPJ no qual o médico entra como sócio de capital simbólico), em vez de receberem como pessoa física ou manterem a própria PJ. A Pin emite a nota fiscal, recolhe/recebe os valores, retém uma alíquota fixa (~15%, que engloba impostos, custos e margem) e repassa o líquido ao médico como distribuição de lucro (isenta de IRPF), em regime de caixa, em até 48h úteis após o recebimento do hospital.

Hoje a operação é manual (solicitação por WhatsApp, emissão pela secretária no Conta Azul ou no site da prefeitura, conciliação em planilha). O objetivo da plataforma é automatizar a esteira ponta a ponta — produção → emissão → recebimento → conciliação → repasse — e a gestão fiscal/financeira da Pin, de forma que a operação escale dos atuais **~50 documentos/mês** para uma base-alvo de **3.000–5.000 médicos em ~3 anos**, sem crescer a equipe na mesma proporção.

2. Objetivos do MVP e métricas de sucesso

Objetivos

1. Automatizar a emissão recorrente de NFS-e a partir da produção informada pelo médico.
2. Dar ao médico um portal com extrato, notas, repasses e solicitação de emissão.
3. Automatizar o cálculo do líquido (85%) e o repasse via PIX após o recebimento.
4. Dar à gestão da Pin a visão de apuração de tributos, lucro e teto fiscal por CNPJ.
5. Nascer multi-empresa (vários CNPJs), com roteamento de médicos por capacidade de faturamento.

Métricas de sucesso

- Redução do tempo de emissão (hoje horas a 1 dia) para minutos no fluxo recorrente.

- % de notas emitidas sem intervenção humana (meta: alta após a 1ª competência validada por médico×serviço).
- Tempo médio de repasse mantido em poucas horas mesmo com crescimento da base.
- Conciliação: % de pagamentos casados automaticamente a uma nota.
- Operação atendendo a base crescente sem aumento proporcional das 3 pessoas atuais.

3. Escopo

No MVP (Fase 1)

- Autenticação, RBAC e multi-tenant por CNPJ.
- Cadastros: médico/sócio, empresa (CNPJ), tomador, serviço com regra fiscal.
- Onboarding (convite → docs → análise de conduta → contrato Clicksign → ativação após faturamento).
- Emissão de NFS-e automatizada (via agregador/Ambiente Nacional) com validação das primeiras notas e fila de exceção; escrituração no Conta Azul.
- Motor de cálculo fiscal (equiparação por CNAE+serviço; destaque padronizado; líquido 85%).
- Conta virtual / ledger por médico e extrato.
- Recebimento + conciliação (Inter/BTG) e repasse PIX (com split acima de R\$ 40 mil).
- Módulo de Gestão e Apuração Fiscal da Pin.
- Benefícios: registro de elegibilidade (sem integração).
- Notificações por e-mail.
- Auditoria e LGPD.

Fora do MVP (Fase 2+)

- Antecipação de recebíveis (produto) e tratamento de risco de glosa.
- Integração com Wellhub/TotalPass (API) e clube de descontos.
- Notificações via WhatsApp (API oficial).
- IRPF/informe de rendimentos do médico; cadastro de dependentes.
- Planos free/plus/premium (a definir).
- Empresas não-médicas (sem clientes hoje).
- Tráfego de dados clínicos de paciente.
- App mobile nativo (MVP é web responsivo).

4. Personas e perfis (RBAC)

Perfil	Descrição	Acesso
Médico (sócio)	Cliente; informa produção, acompanha extrato/repases	Portal do médico (próprios dados)
Secretária / Operação	Valida e acompanha emissões, trata fila de exceção	Emissão, exceções, cadastros
Financeiro	Conciliação e aprovação de repasses	Recebimentos, repasses, caixa
Contábil / Fiscal	Apuração, guias, regras fiscais	Apuração, calendário, parametrização fiscal
Gestão / Admin	Visão gerencial e configuração	Tudo + painéis + auditoria

Transversais: isolamento multi-tenant por CNPJ, menor privilégio, e trilha de auditoria de toda ação fiscal/financeira (quem informou produção, emitiu, aprovou, repassou).

5. Modelo de negócio e premissas fiscais (fundação)

5.1 Estrutura societária e multi-empresa

- O médico entra como sócio com ~0,01% de capital — mecanismo legal para receber o repasse como **distribuição de lucro** (isenta de IRPF). A entrada exige **alteração contratual na Junta Comercial** (prazo da autarquia, ~15–60 dias). A assinatura via Clicksign cobre o contrato de proteção jurídica e termos de uso (não substitui a Junta).
- A operação é **multi-empresa** (holding/rede): já existe um 2º CNPJ em Eusébio/CE (ISS 2%, fora de operação). Novos médicos são alocados a um CNPJ por capacidade de faturamento, para respeitar o teto do Lucro Presumido (R\$ 78 mi/ano por CNPJ).
- Um médico pode estar vinculado a mais de um CNPJ (relação N:N).

5.2 Tributação (Lucro Presumido, com equiparação hospitalar)

- A Pin apura por **Lucro Presumido**, com **equiparação hospitalar** para os serviços elegíveis.
- Destaque padronizado em todas as notas:** ISS 2% · IR 1,5% · CSLL 1% · PIS 0,65% · COFINS 3%.
- Item da LC 116:** 4.02 e 4.03. CNAEs já mapeados (8610-1/01, 8610-1/02, 8630-5/01, 8640-2/07, 8640-2/08).
- Reforma tributária (IBS/CBS) NOVO** — serviços de saúde humana classificados no item **200029** da NBS, enquadrados no **Anexo III** com **redução de 60%** da alíquota; início da cobrança em **2027** (fase-teste de 1%). Tratado como premissa parametrizável por competência (ver RF-FISC-04); enquadramento e alíquotas a homologar com a contabilidade conforme a regulamentação evolui.
- Equiparação hospitalar** é determinada por **CNAE + tipo de serviço** (parametrizável). Serviços com equiparação usam presunção reduzida (IR efetivo ~1,67%; CSLL ~1,08%); sem equiparação, presunção cheia (IR ~7,62%; CSLL ~2,88%).
- ~95% das notas** têm retenção federal na fonte pelo hospital (IR, PIS, COFINS, CSLL). A Pin recolhe o ISS (2%). Os demais tributos são **apurados mensalmente; PIS/COFINS em regime de caixa**. ISS: Olinda 2%, recolhido pela Pin no domicílio fiscal. Risco conhecido: há casos de bitributação de ISS quando o tomador retém por entendimento diverso; hoje a Pin absorve o custo (ver Riscos, Seção 14).

Caso paciente pessoa física (CPF) com equiparação hospitalar NOVO

A NFS-e é emitida com **impostos zerados** (sem destaque na nota) e **sem retenções na fonte**. Os tributos correspondentes são **apurados pela contabilidade e recolhidos separadamente** (fora da nota). O líquido ao médico permanece em **85%** — muda apenas a forma de composição/recolhimento, não o valor recebido. (Reflexo em RF-NF-02 e RF-FISC-02.)

5.3 Composição do valor (exemplo de referência)

Nota de **R\$ 10.000** a hospital, com retenção federal. O médico **sempre recebe 85%**; os 15% englobam impostos (inclusive ISS), custos e margem da Pin.

Linha do extrato do médico	Valor	Observação
Crédito da nota (bruto)	R\$ 10.000,00	valor da NFS-e
(-) Retenções federais na fonte (6,15%)	– R\$ 615,00	retido pelo hospital
(-) ISS (2%)	– R\$ 200,00	recolhido pela Pin (dentro dos 15%)
(-) Taxa administrativa (complemento até 15%)	– R\$ 685,00	retido pela Pin; exibida como "taxa administrativa gratuita"
= Repasse (85%)	R\$ 8.500,00	distribuição de lucro (isenta IRPF)

Tomador pessoa física (sem retenção): crédito R\$ 10.000 – taxa administrativa R\$ 1.500 (que já contempla os tributos) = repasse R\$ 8.500. O líquido ao médico é o mesmo; muda apenas a composição interna. A diferença entre o destaque padronizado e o imposto realmente apurado fica dentro dos 15% (custo/margem da Pin) — o médico nunca é impactado por ela.

Variante CPF com equiparação hospitalar: a nota sai com impostos zerados e sem retenção (ver §5.2). A "taxa administrativa" segue garantindo o líquido de 85% ao médico, e os tributos são recolhidos à parte pela contabilidade — o resultado financeiro para o médico é idêntico (R\$ 8.500 no exemplo).

6. Arquitetura de alto nível

- **Frontend:** React (portal do médico + backoffice; SPA responsiva).
- **Backend:** Java 17 / Spring Boot, modular por domínio (hexagonal), API REST.
- **Banco:** PostgreSQL, multi-tenant por CNPJ (empresa como chave de isolamento).
- **Processamento assíncrono:** filas para emissão fiscal, conciliação e repasse (operações dependentes de terceiros, com retry e idempotência).
- **Segurança:** OAuth2/OIDC, MFA para perfis administrativos, certificados A1 em cofre de segredos (secrets/HSM) — um A1 por CNPJ.
- **Integrações** isoladas atrás de adapters (agregador fiscal, banco/BaaS, Clicksign, Conta Azul, e-mail), para permitir troca de fornecedor.
- Observabilidade e auditoria ponta a ponta.

7. Módulos funcionais

7.1 Autenticação, acesso e multi-tenant

- **RF-AUTH-01:** cadastro/convite, login, recuperação de senha, expiração de sessão.
- **RF-AUTH-02:** MFA obrigatório para Operação, Financeiro, Contábil e Gestão.
- **RF-AUTH-03:** RBAC por perfil (Seção 4) e isolamento por CNPJ (um usuário pode ter acesso a 1..N empresas).
- **RF-AUTH-04:** trilha de auditoria de ações sensíveis.

7.2 Cadastros

- **RF-CAD-01:** Médico/sócio — CRM, especialidade, CPF, dados pessoais, dados bancários (PIX), CPFs adicionais para split de repasse, documentos (CRM, diploma, CNH, comprovante de residência).
- **RF-CAD-02:** Empresa (CNPJ) — razão social, CNPJ, inscrição municipal, regime, certificado A1, conta bancária, município (Olinda, Eusébio...). (Premissa: cada CNPJ tem A1, IM e conta próprios — confirmar N3.)
- **RF-CAD-03:** Tomador — hospital/clínica/operadora/paciente PF; dados fiscais e indicador de retenção.
- **RF-CAD-04:** Serviço com regra fiscal — código LC 116 (4.02/4.03), CNAE, indicador de equiparação hospitalar, discriminação padrão, alíquotas de destaque.
- **RF-CAD-05:** Plano (conceito modelado, sem regras no MVP) — para futura diferenciação free/plus/premium.

7.3 Onboarding e KYC

- **RF-ONB-01..07:** convite/indicação → cadastro → upload de documentos → análise de conduta (checklist: nº do conselho, registros disciplinares, processos sobre ato médico) → assinatura do contrato via Clicksign → registro da alteração contratual na Junta Comercial (status acompanhado, prazo ~15–60 dias) → ativação → liberação de benefícios após faturamento ativo.
- **RF-ONB-08:** alteração de dados bancários exige reconfirmação (token/aprovação) por risco de fraude.
- **RF-ONB-09:** o checklist de conduta fica registrado para auditoria, mesmo quando preenchido manualmente.

7.4 Emissão de NFS-e

- **RF-NF-01:** gatilho = confirmação da produção do médico no portal (tomador, valor, competência, descrição).
- **RF-NF-02:** aplica a regra fiscal do serviço (equiparação, destaque, LC 116, CNAE). **Inclui o modo "nota com impostos zerados" para paciente CPF com equiparação hospitalar** — sem destaque e sem retenção na nota, com os tributos tratados na apuração mensal (ver §5.2 e RF-FISC-02).

- **RF-NF-03:** emissão nativa via agregador fiscal (PlugNotas/Focus/Nuvem Fiscal/NFE.io) ou Ambiente Nacional da NFS-e (Olinda no Padrão Nacional), assinada com o A1 do CNPJ. **Decisão M1: a plataforma substitui o Conta Azul na emissão.**
- **RF-NF-04:** escrituração no Conta Azul das notas emitidas (ERP segue como fonte contábil, capturando inclusive notas emitidas fora).
- **RF-NF-05:** validação interna das 2 primeiras notas por médico×serviço novo; auto-emissão liberada após a 1ª competência validada.
- **RF-NF-06:** fila de exceção (sempre revisão humana): tomador novo, serviço sem regra fiscal cadastrada.
- **RF-NF-07:** status (rascunho → validação → processando → emitida/rejeitada/cancelada); XML + PDF (DANFSE) disponíveis.
- **RF-NF-08:** cancelamento/substituição com motivo (ex.: valor informado errado) e trilha.
- **RF-NF-09:** fallback operacional para emissão manual quando o serviço da prefeitura/agregador estiver indisponível.

7.5 Motor de cálculo fiscal

- **RF-FISC-01:** determina equiparação por CNAE + tipo de serviço.
- **RF-FISC-02:** calcula o destaque da nota (ISS 2%, IR 1,5%, CSLL 1%, PIS 0,65%, COFINS 3%) e o líquido do médico (85%). **Suporta a variante de destaque zerado para tomador CPF com equiparação hospitalar**, em que a nota não carrega impostos nem retenções e o tributo devido é calculado na apuração mensal (§7.9) — preservando os 85% ao médico.
- **RF-FISC-03:** registra retenções na fonte sofridas (por tomador) como crédito para a apuração mensal.
- **RF-FISC-04:** toda alíquota/base é parametrizável por competência (a tributação pode mudar — inclusive a transição IBS/CBS a partir de 2027; o motor não pode ter número "chumbado").

7.6 Conta virtual / ledger do médico

- **RF-LED-01:** ledger por médico com lançamentos: crédito da nota, retenções, ISS, taxa administrativa, repasse, ajustes.
- **RF-LED-02:** saldo em regime de caixa (só há repasse após o hospital pagar); por padrão, todo recebimento é repassado (sem carteira).
- **RF-LED-03:** extrato filtrável e exportável (PDF/CSV).
- **RF-LED-04:** conciliação do ledger com a contabilidade oficial (repasse = distribuição de dividendos).

7.7 Recebimento e conciliação

- **RF-REC-01:** leitura dos recebimentos da conta da Pin via API bancária / Open Finance (bancos Inter e BTG).
- **RF-REC-02:** matching pagamento ↔ nota. (Premissa O2, a validar: hoje não há identificador no pagamento; matching sugerido por valor + tomador + data, com confirmação humana, evoluindo para automático.)
- **RF-REC-03:** baixa do recebimento → crédito no ledger do médico (médico como centro de custo, como já feito no Conta Azul).

7.8 Repasse

- **RF-REP-01:** cálculo do líquido = 85% do bruto da produção do médico, autorizado após o recebimento.
- **RF-REP-02:** execução via PIX (idealmente BaaS) para a conta PF do médico.
- **RF-REP-03:** para valores acima do limite de R\$ 40 mil da conta PF, dividir em parcelas para CPF(s) adicionais indicados pelo médico.
- **RF-REP-04:** aprovação (hoje manual, conforme produção); evoluir para automática até um teto e manual acima.
- **RF-REP-05:** comprovante, status (autorizado → enviado → liquidado → falhou) e histórico; SLA de 48h úteis (hoje poucas horas).

7.9 Módulo de Gestão e Apuração Fiscal da Pin

Responde à dúvida sobre "o que a Pin paga e o lucro do mês". Visão da gestão, por CNPJ e competência. (Proposta de desenho; fórmulas a homologar com a contabilidade.)

a) Apuração mensal de tributos (Lucro Presumido)

1. Receita da competência (PIS/COFINS por caixa; IRPJ/CSLL conforme opção).
2. Base presumida: equiparação → IRPJ 8% / CSLL 12%; sem equiparação → 32%.
3. Tributos devidos: IRPJ 15% (+ adicional 10% sobre base que exceder R\$ 20 mil/mês) · CSLL 9% · PIS 0,65% · COFINS 3% · ISS 2%.
4. (-) Retenções na fonte já sofridas (crédito/antecipação).
5. = Saldo a recolher por tributo, com guias (DARF federal + guia municipal ISS) e vencimentos.

Nota: as notas de paciente CPF com equiparação (emitidas zeradas) e a futura sistemática IBS/CBS entram justamente aqui — os tributos são calculados na apuração mensal e não no destaque da nota.

b) DRE simplificada / apuração de lucro

Receita bruta – tributos – custos operacionais = lucro antes da distribuição – distribuição de lucro aos médicos (85% das respectivas produções) = resultado/margem da Pin (~2–5%).

c) Monitor de teto fiscal

Receita acumulada (12 meses) por CNPJ vs R\$ 78 mi, com alerta de proximidade que aciona o roteamento de novos médicos para outro CNPJ (liga-se ao RF-CAD-02/N1).

d) Posição de caixa

A receber dos hospitais (notas emitidas não pagas), a repassar (recebido não repassado), repassado e (Fase 2) antecipações concedidas.

e) Calendário fiscal

Vencimentos de guias por CNPJ, com lembretes para a gestão (não exposto ao médico).

7.10 Benefícios

- **RF-BEN-01:** registrar elegibilidade (faturamento ativo) para Wellhub/TotalPass. Integração via API fica para a Fase 2.

7.11 Notificações

- **RF-NOT-01:** e-mail (Fase 1) para eventos: nota emitida/rejeitada, repasse efetuado, pendência de cadastro/documento. WhatsApp (Cloud API) na Fase 2.

7.12 Portal do médico

- **RF-PORT-01:** dashboard (saldo, próximos/últimos repasses, notas, status).
- **RF-PORT-02:** informar produção e solicitar emissão.
- **RF-PORT-03:** extrato, notas (XML/PDF) e comprovantes de repasse.
- **RF-PORT-04:** edição limitada de cadastro; dados bancários com reconfirmação (RF-ONB-08).

7.13 Backoffice / Admin

- **RF-ADM-01:** gestão de médicos, empresas, tomadores e serviços/regras fiscais.
- **RF-ADM-02:** filas de validação de notas e aprovação de repasse.
- **RF-ADM-03:** conciliação e fechamento.
- **RF-ADM-04:** painéis da Seção 7.9 e exportações.

7.14 Auditoria e LGPD

- **RF-LGPD-01:** trilha de auditoria de ações fiscais/financeiras.

- **RF-LGPD-02:** retenção de documentos fiscais (5 anos) e política de dados pessoais.
- **RF-LGPD-03:** dados de paciente PF (CPF/nome em notas) tratados conforme LGPD; dados clínicos ficam fora do MVP.

8. Modelo de dados (entidades principais)

- **Empresa** (CNPJ, IM, A1, conta, município) — tenant.
- **Usuario** (acesso, perfil) — N:N com Empresa.
- **Medico** (PF, CRM, banco, CPFs de split, documentos).
- **VinculoMedicoEmpresa** (N:N: médico ↔ empresa; status societário, alteração contratual/Junta).
- **Tomador** (hospital/clínica/operadora/paciente PF; indicador de retenção).
- **Servico** (LC 116, CNAE, equiparação, alíquotas de destaque, discriminação).
- **Producao** (médico, tomador, serviço, valor, competência) → origina a nota.
- **NotaFiscal** (vínculo a Empresa emissora, status, XML/PDF, destaque, retenções).
- **ContaMedico / LancamentoLedger** (crédito, retenção, ISS, taxa adm, repasse).
- **Recebimento** (entrada bancária, matching com nota).
- **Repasse** (líquido, parcelas/CPFs, status, comprovante).
- **ApuracaoFiscal** (por empresa/competência: bases, tributos, retenções, guias).
- **Documento, ChecklistConduta, Beneficio, Notificacao, Auditoria, Convite.**

Relações-chave: Empresa 1:N Nota, Medico N:N Empresa, Producao 1:1 Nota, Nota 1:N Lancamento, Recebimento N:1 Nota (ou N:N em pagamentos em lote — a confirmar).

9. Integrações externas

Integração	Finalidade	Fase
Agregador fiscal / Ambiente Nacional NFS-e	Emitir NFS-e (Olinda no Padrão Nacional)	1
Conta Azul	Escrituração contábil das notas	1
Banco (Inter / BTG) — API / Open Finance	Ler recebimentos para conciliação	1
BaaS	Repasse PIX (com split)	1
Clicksign	Assinatura do contrato de adesão	1
E-mail transacional	Notificações	1
Receita/CNPJ	Consulta cadastral	1 (consulta)
WhatsApp Cloud API	Notificações	2
Wellhub / TotalPass	Benefícios	2

10. Fluxos principais

Onboarding: convite → cadastro + docs → checklist de conduta → contrato (Clicksign) → alteração contratual na Junta (acompanhamento de status) → ativação → benefícios após faturamento.

Emissão recorrente: médico informa produção no portal → motor aplica regra fiscal → (2 primeiras notas do médico×serviço passam por validação) → emissão via agregador/Ambiente Nacional com A1 do CNPJ → escrituração no Conta Azul → lançamento no ledger. Exceções (tomador novo / serviço sem regra) vão para revisão.

Recebimento → **repass**: hospital paga (TED/PIX) → leitura via API bancária → matching com a nota (sugestão + confirmação) → baixa e crédito no ledger → cálculo do líquido (85%) → aprovação → PIX (split se > R\$ 40 mil) → comprovante.

Apuração mensal (gestão): consolidação por CNPJ → bases presumidas (equiparação) → tributos devidos – retenções → saldo a recolher + guias/vencimentos → DRE/lucro → monitor de teto.

11. Requisitos não-funcionais

- **Segurança**: A1 em cofre; criptografia de CPF/dados bancários; MFA administrativo.
- **Escala**: suportar a base-alvo (3–5 mil médicos) e picos nos dias 1–7 de cada mês (emissão concentrada).
- **Resiliência**: filas com retry/idempotência para emissão, conciliação e repasse.
- **Auditoria/LGPD**: trilhas completas; retenção fiscal de 5 anos.
- **Disponibilidade e backup**: parametrização fiscal por competência (sem valores fixos em código).
- **Multi-tenant** por CNPJ com isolamento de dados.

12. Faseamento

Fase	Conteúdo
1 — MVP	Auth/RBAC, cadastros, onboarding, emissão automatizada + escrituração, motor fiscal, ledger, conciliação, repasse PIX, gestão/apuração, benefícios (elegibilidade), e-mail, auditoria/LGPD.
2	Antecipação + risco de glosa, WhatsApp, integração Wellhub/TotalPass, IRPF/informe, planos free/plus/premium, controle de produção de vários médicos para o mesmo tomador (ex.: ~40 médicos no mesmo hospital) .
Futuro	App nativo, dados clínicos de paciente, empresas não-médicas.

13. Premissas e questões em aberto

1. **N3 — Cada CNPJ com A1/IM/conta próprios**: assumido como sim; **confirmar**.
2. **O2 — Conciliação sem identificador**: assumido matching por valor+tomador+data com confirmação humana; **validar** se há como incluir um identificador no pagamento (reduz muito o trabalho manual).
3. **Apuração (Seção 7.9)**: desenho proposto; **homologar fórmulas** (bases, adicional de IRPJ, regime de caixa) com a contabilidade. **Os apontamentos da operação sobre nota CPF zerada e transição IBS/CBS já foram incorporados (§5.2); a homologação das fórmulas de apuração segue pendente.**
4. **Planos free/plus/premium**: sem regras definidas; modelado apenas como conceito.
5. **Pagamentos em lote pelo hospital** (uma transferência cobrindo várias notas): confirmar se ocorre, para modelar Recebimento N:N Nota.
6. **Reforma tributária (IBS/CBS)**: acompanhar a regulamentação para confirmar enquadramento (NBS 200029 / Anexo III, redução de 60%) e o cronograma de alíquotas a partir de 2027; manter parametrizável (RF-FISC-04).

14. Riscos

- **Teto do Lucro Presumido (R\$ 78 mi/CNPJ)**: mitigado pelo desenho multi-empresa + monitor de teto; exige disciplina de roteamento.
- **Enquadramento de equiparação hospitalar**: depende de CNAE/serviço e de requisitos legais; o motor deve permitir reclassificar e a contabilidade valida o enquadramento.
- **Conciliação sem identificador**: principal risco de escala da operação manual; endereçar O2 cedo.
- **Alteração contratual na Junta (15–60 dias)**: cria lead time no onboarding antes do faturamento ativo; o sistema acompanha status mas não controla o prazo da autarquia.
- **Bitributação de ISS** em tomadores de outros entendimentos: custo hoje absorvido; registrar e monitorar.

- **Dependência de terceiros** (agregador/banco/BaaS): isolar por adapters e tratar indisponibilidade (fallback de emissão).
- **Transição tributária IBS/CBS**: mudança estrutural de regime a partir de 2027; risco de retrabalho no motor fiscal se não houver parametrização por competência desde o MVP.

PRD v1.1 — base aprovada para o backlog do MVP. As decisões fiscais são parametrizáveis e devem ser homologadas pela contabilidade da Pin.